

Perianal Hastalık ve Anal Fissür

Tipik basit anal fissürün konservatif yönetimini; atipik/kompleks perianal hastalıkta (perianal Crohn, immün yetmezlik, apse-fistül) muayene, basamaklı tetkik ve dozlu tedaviden ayırt eden karar algoritması.

Anal fissür

Perianal Crohn

Apse-fistül

İmmün yetmezlik

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Anal fissür, anal kanal anodermindeki lineer yırtıktır ve süt çocuğu/çocukta ağrılı taze rektal kanamanın en sık nedenidir; tipik olgu tek, orta hat (posterior veya anterior) yerleşimli olup sert dışkı-kabızlık ile ilişkilidir. "Perianal hastalık" ise fissürün yanı sıra perianal apse, fistül-in-ano, cilt etiketleri (skin tag), perianal dermatit, rektal prolapsus ve hemoroidi kapsayan bir şemsiye terimdir. Kritik klinik görev, kendini sınırlayan basit fissürü; altta perianal Crohn hastalığı, immün yetmezlik (KGH, nötropeni, lösemi, HIV) veya istismarı düşündüren atipik/kompleks tablodan ayırmaktır. Lateral, çoklu, derin veya ağrısız fissür; ödematöz "fil kulağı" etiketleri; fistül ağzı ve tekrarlayan apse basit fissür tanısını dışlar.

Öykü

- Ağrı-defekasyon ilişkisi, taze kanamanın niteliği (dışkı yüzeyinde/tuvalet kağıdında damlama), akıntı, şişlik, kaşıntı
- Dışkı sıklığı-kıvamı (Bristol), kabızlık, retansiyon postürü, ağrılı defekasyondan kaçınma davranışı
- Semptom süresi ve tekrarı; iyileşmeyen/nükseden fissür veya apse öyküsü
- Sistemik/GİS: kilo kaybı, büyüme duraklaması, kronik ishal, mukuslu-kanlı dışkı, karın ağrısı, aftöz ülser, artralji (Crohn ipuçları)
- Enfeksiyon eğilimi: tekrarlayan cilt/derin doku apsesi, geç düşen göbek kordonu, ateşli nötropeni öyküsü (immün yetmezlik)
- Kolay morarma, solukluk, kemik ağrısı, ateş (lösemi); psikososyal öykü ve istismar açısından uyumsuzluk

Fizik muayene

- Pozisyon: lateral dekübit veya prone diz-göğüs; nazik gluteal separasyon ile anal kanalın görsel muayenesi
- Fissür karakterizasyonu: yer (orta hat vs. lateral/çoklu), derinlik, sentinel etiket, ağrı; tipik fissür posterior orta hatta
- Perianal inspeksiyon: ödematöz-mor cilt etiketleri, fistül ağzı, indürasyon, fluktuan apse, eritem, anal stenoz
- Perianal streptokok: keskin sınırlı parlak kırmızı eritem, fissür, kaşıntı-ağrı
- Ekstraintestinal Crohn taraması, büyüme parametreleri, oral aftöz ülser

- Dijital rektal muayene akut ağrılı fissürde ertelenir; gerekirse anestezi altında muayene (EUA) planla

Basit fissür klinik tanıdır ve ek tetkik gerektirmez; atipik lokalizasyon (lateral/çoklu), ağrısızlık, indürasyon veya eşlik eden fistül/apse, tanıyı "perianal Crohn / immün yetmezlik" yönüne kaydırır ve hedefli inceleme gerektirir.

02 Etiyoloji ve mekanizma

Perianal bulgunun kaynağını sınıflamak tedavi yolunu belirler: en sık senaryo kabızlığa bağlı basit fissür olsa da, atipik/kompleks tabloda inflamatuvar, enfeksiyöz ve immün nedenler dışlanmalıdır.

Basit / tipik anal fissür (en sık)

- Sert dışkı + kabızlık → anoderm yırtığı
- Orta hat (posterior > anterior), tek, ağrılı, taze kan
- İnternal sfinkter hipertoni ve iskemi ile kronikleşme

Perianal Crohn hastalığı

- Lateral/çoklu, derin, sıklıkla ağrısız fissür
- Ödematöz "fil kulağı" cilt etiketleri, fistül, apse, anal stenoz
- Sistemik/GİS bulgu ve büyüme geriliği eşlik eder

Perianal apse / fistül-in-ano

- Kriptoglandüler kaynak; süt çocuğunda (<2 yaş, erkek) sık
- İnfantil olguların çoğu benign, sıklıkla kendini sınırlar
- Tekrarlayan/kompleks fistül → Crohn veya immün yetmezlik uyarısı

İmmün yetmezlik

- Kronik granüloamatöz hastalık (KGH), ağır konjenital/sıklık nötropeni
- Lösemi/nötropeni, HIV, immünsupresyon
- Atipik, tekrarlayan, iyileşmeyen apse/ülser

Enfeksiyöz / dermatolojik

- Perianal streptokok dermatiti (A grubu strep)
- Kandida/dermatit, molluscum, kondiloma
- Liken sklerozus, psöriazis

Diğer / kırmızı bayrak

- Rektal prolapsus (kistik fibrozis dışı)
- Hemoroid nadir → portal hipertansiyon araştır
- Cinsel istismar: açıklanamayan/atipik travma, davranışsal ipuçları

03 Karar akışı

İlk kritik ayırım, bulgunun tipik basit fissür mü yoksa atipik/kompleks perianal hastalık mı olduğudur; tipik olgu doğrudan konservatif tedaviye girerken, atipik özellik apse drenajı ve Crohn/immün yetmezlik taramasını tetikler.

BAŞLANGIÇ

Perianal ağrı, kanama, şişlik veya akıntı ile başvuru

Öykü + hedefli perianal inspeksiyonla tipik/atipik ayırımı yap.

ADIM 1

Perianal muayene ve karakterizasyon

Fissür yeri-derinliği, cilt etiketi, fistül ağzı, fluktuasyon, indürasyon; ağrılı olguda gerekirse EUA planla.

KARAR 1

Tipik basit fissür mü?

Tek, orta hat, ağrılı fissür + kabızlık/sert dışkı; atipik özellik ve alarm yok.

EVET → basit fissür yolu

HAYIR → atipik / kompleks

KONSERVATİF TEDAVİ

Kabızlık tedavisi + sitz banyosu + topikal bariyer/anestezik

PEG 3350 ile yumuşak dışkı sağla; 6-8 haftada çoğu fissür iyileşir. İyileşmezse Karar 3'e geç.

KARAR 2

Fluktuan apse / aktif enfeksiyon var mı?

Ağrılı, eritemli, fluktuan kitle veya pürülan akıntı.

APSE VAR → drenaj

APSE YOK → sistemik tarama

İNSİZYON-DRENAJ + NEDEN ARA

İ&D; tekrarlayan/atipik apsede immün yetmezlik ve Crohn tara

İnfantil basit apse sıklıkla benign; tekrarlayan/kompleks apsede TKS-yayma, DHR/NBT, kalprotektin iste.

CROHN / İMMÜN YETMEZLİK TARAMASI

Fekal kalprotektin, CRP-ESH, TKS-yayma, ileokolonoskopi

Lateral/çoklu fissür, etiket, fistül veya sistemik bulguda hedefli tetkik başlat.

KARAR 3

Crohn veya immün yetmezlik doğrulandı mı?

Kolonoskopi/histoloji, MRG fistül haritası, immün tetkik sonuçları.

EVET → hastalığa yönelik tedavi

HEDEFLİ, MULTİDİSİPLİNER

Anti-TNF ± antibiyotik ± seton; immün yetmezlikte etkene yönelik

Perianal fistülizan Crohn'da infliksimab + cerrahi seton; gastroenteroloji-cerrahi-immünoloji ortak yönetimi.

HAYIR → idiyopatik/refrakter fissür

KRONİK FİSSÜR BASAMAĞI

Topikal GTN veya kalsiyum kanal blokeri; dirençlide botulinum

Yeterli osmotik laksatif + topikal kimyasal sfinkterotomi; yanıtızlıkta botulinum toksin, seçili olguda cerrahi.

Tipik basit fissür klinik tanıdır ve tetkik gerektirmez; incelemeler atipik lokalizasyon, tekrarlayan/kompleks apse-fistül, sistemik bulgu veya konservatif tedaviye direnç varlığında basamaklı istenir.

Perianal hastalık / anal fissürde basamaklı tetkik yaklaşımı		
BASAMAK	ENDİKASYON / EŞİK	YORUM
Klinik değerlendirme + inspeksiyon	Tüm olgular	Tipik basit fissürde ek tetkik gereksiz; atipik özellik varlığında ilerle
Perianal sürüntü kültürü	Keskin sınırlı parlak eritem, dirençli perianal dermatit	A grubu beta-hemolitik streptokok; hızlı antijen testi de kullanılabilir
Tam kan sayımı + periferik yayma	Tekrarlayan/atipik apse, solukluk, morarma, ateş	Nötropeni ve lösemi taraması; blast/sitopeni araştır
İnflamatuvar belirteçler + fekal kalprotektin	Lateral/çoklu fissür, etiket, fistül, sistemik/GİS bulgu	CRP, ESH, albümin; yüksek kalprotektin Crohn için ileokolonoskopiye tetikler
İleokolonoskopi + biyopsi	Perianal Crohn şüphesi	Tanısal altın standart; üst endoskopi ile birlikte tam değerlendirme
Pelvik MRG	Fistülizan perianal hastalık, kompleks/tekrarlayan fistül	Fistül trakt haritalaması ve apse tespiti; tedaviyi ve cerrahiyi yönlendirir
Anestezi altında muayene (EUA)	Ağrılı/kompleks perianal hastalık, seton planı	Tanı + drenaj/seton; MRG ile tamamlayıcı, cerrahi ile ortak

BASAMAK	ENDİKASYON / EŞİK	YORUM
İmmün tetkik	Tekrarlayan/iyileşmeyen atipik apse-fistül, erken başlangıç	DHR/NBT testi (KGH), immünglobulinler, lenfosit alt grupları, HIV serolojisi

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular basit fissür tanısını dışlar ve perianal Crohn, immün yetmezlik, malignite veya istismar yönünde hedefli inceleme gerektirir.

- Lateral, çoklu, derin veya ağrısız fissür (orta hat dışı yerleşim)
- Ödematöz-mor "fil kulağı" cilt etiketleri, fistül ağzı, indürasyon, anal stenoz
- Tekrarlayan veya iyileşmeyen perianal apse; kompleks fistül-in-ano
- Sistemik/GİS: kilo kaybı, büyüme duraklaması, kronik ishal, mukuslu-kanlı dışkı, aftöz ülser (Crohn)
- Tekrarlayan cilt/derin doku enfeksiyonu, geç kordon düşmesi, ateşli nötropeni öyküsü (immün yetmezlik/KGH)
- Solukluk, kolay morarma, peteşi, hepatosplenomegali (lösemi)
- Fissür yokluğunda tekrarlayan rektal kanama veya hemoroid → portal hipertansiyon
- Açıklanamayan/atipik anal travma, öykü uyumsuzluğu, davranışsal ipuçları → istismar değerlendirmesi

06 Tedavi (dozlu)

Basit fissürde temel: kabızlığı çözerek yumuşak-ağrısız dışkılama sağlamak (osmotik laksatif), sitz banyosu, topikal bariyer/anestezik. Kronikleşen fissürde topikal kimyasal sfinkterotomi (GTN veya kalsiyum kanal blokeri), dirençlide botulinum toksin. Perianal apsede insizyon-drenaj; perianal Crohn ve immün yetmezlikte etkene yönelik sistemik tedavi ve cerrahi ile birlikte yürütülür.

Önce kabızlığı çöz: fissürlerin çoğu, sert dışkı döngüsü kırılıp yumuşak dışkılama sağlandığında konservatif tedaviyle 6-8 haftada iyileşir. Ailenin ağrı-tutma kısır döngüsünü ve düzenli laksatif kullanımını anlaması esastır.

Anal fissür ve perianal hastalıkta basamaklı farmakoterapi

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
PEG 3350 — osmotik laksatif (idame)	0.4-0.8 g/kg/gün (maks ~17 g/gün)
Laktuloz — osmotik alternatif	1-2 g/kg/gün (1-3 mL/kg/gün), 1-2 doza k
Sitz banyosu + bariyer/anestezik	Ilık su 10-15 dk, günde 2-3 kez; topikal %
Topikal gliseril trinitrat (GTN) %0.2 — kronik fissür	Perianal ince tabaka, günde 2 kez, 6-8 h
Topikal diltiazem %2 — kronik fissür (KKB)	Perianal günde 2 kez, 6-8 hafta
Botulinum toksin A — dirençli kronik fissür	İnternal sfinktere ~ 0.5-1 Ü/kg (tipik topl

İLAÇ / BASAMAK	DOZ
Amoksisilin-klavulanat — enfekte/selülitli apse	40-50 mg/kg/gün (amoksisilin), 2-3 doz (
Metronidazol — perianal Crohn / apse	15-20 mg/kg/gün, 3 doz (maks 1-1.5 g/gü
Siprofloksasin — perianal Crohn	20-30 mg/kg/gün, 2 doz (maks 1.5 g/gün
İnfliksimab — perianal fistülizan Crohn (birinci basamak)	5 mg/kg IV, 0-2-6. hafta indüksiyon, sonu
Azatioprin — immünomodülatör (adjuvan)	2-2.5 mg/kg/gün, tek doz

Kabızlık tedavisi / yumuşak dışkı

Sitz banyosu

Lif + sıvı optimizasyonu

Seton drenajı (fistül)

Multidisipliner (GE-cerrahi-immünoloji)

Perianal fistülizan Crohn ve immün yetmezlik ilişkili tekrarlayan apse-fistül; tek başına ilaç veya tek başına cerrahi ile değil, kombine medikal-cerrahi (seton drenajı + anti-TNF) ve etkene yönelik immünolojik yönetimle ele alınmalıdır. İnfantil basit fissür/apsede agresif cerrahiden kaçınılır.

Basit fissür yönetiminin başarısı, kabızlığın yeterli süreyle kontrol altında tutulmasına bağlıdır; kompleks perianal hastalıkta izlem, altta yatan tanı (Crohn/immün yetmezlik) çerçevesinde ve multidisipliner yürütülür.

Basit fissür izlemi

- 2-4 haftada kontrol; hedef günde 1 ağrısız, yumuşak (Bristol 4-5) dışkı
- Laksatifi fissür iyileştikten sonra da erken kesmeden sürdür; nüksü önlemek için kademeli azalt
- 6-8 haftada iyileşmeyen fissürde tanıyı yeniden değerlendir ve kronik fissür basamağına/atipik nedenlere geç
- Aile eğitimi: ağrı-tutma döngüsü, sitz banyosu, düzenli laksatif; cezalandırmadan kaçınma
- Perianal streptokokta antibiyotik sonrası eritem ve semptom gerilemesini doğru

Kompleks perianal hastalık izlemi

- Perianal Crohn'da klinik yanıt + MRG ile fistül iyileşmesini izle; anti-TNF terapötik ilaç düzeyi/antikor takibi
- Seton'un kontrollü drenajı ve zamanında çıkarımı; cerrahi ile ortak karar
- İmmün yetmezlikte etkene yönelik tedavi ve enfeksiyon profilaksisi; immünoloji eş yönetimi
- Tekrarlayan/atipik apsede altta yatan tanıyı (KGH, nötropeni) mutlaka dışla ve düzenli hematolojik izlem
- Büyüme, beslenme ve yaşam kalitesi izlemi; psikososyal destek

Yanıtsız veya nükseden perianal hastalıkta önce en sık düzeltilebilir nedenleri değerlendir: yetersiz kabızlık kontrolü ve tedavi uyumsuzluğu. Bunlar giderildiği hâlde iyileşme yoksa perianal Crohn ve immün yetmezliği yeniden gözden geçir.

Kaynaklar

1. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021;15(2):171-194.

2. Gecse KB, Bemelman W, Kamm MA, et al. A global consensus on the classification, diagnosis and multidisciplinary treatment of perianal fistulising Crohn's disease. Gut. 2014;63(9):1381-1392.
3. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al. Evaluation and Treatment of Functional Constipation in Infants and Children: ESPGHAN/NASPGHAN Evidence-Based Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58(2):258-274.
4. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Child/Adolescent (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150(6):1456-1468.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanına yönelik klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve klinik muhakemenin yerini tutmaz. Dozlar ve endikasyonlar uygulama öncesi kaynaklardan ve yerel formüllerden doğrulanmalıdır.